



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : امنيہ عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم

العنوان : المامون

الحى / المدينة : الجيزه

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستماره : 06-10-2026

رقم البطاقة : 29005268800647 رقم التليفون : 01006503863

العمر (تاريخ الميلاد) : 26-05-1990 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امنيه عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم National ID: 29005268800647	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

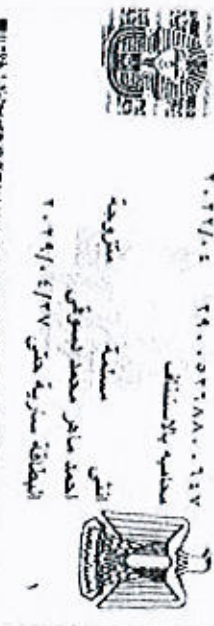
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢



IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Name: أمينة عبد المنعم ابراهيم
PATIENT'S I.D :29005268800647
Age: 32 Y.

TM: 64 /2023

Specimen Received Data: 22 / 02 /2023

Date Report Issued: 26/ 02 /2023

CLINICAL DATA: A case of *right* breast cancer, for estrogen, progesterone receptors, Her-2/neu and Ki-67.

PROCEDURE: Sections from paraffin block were treated with antigen retrieval solution and then treated with monoclonal antibodies for estrogen, progesterone & Her-2/neu, (CONFIRM™ anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit & CONFIRM™ anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2), CONFIRM™ anti-HER-2/neu (4B5) Primary Antibody), and CONFIRM anti-Ki67 (30-9) Primary Antibody), using Ventana IView™ system. DAB was used as a chromogen and hematoxylin as a counter stain.

RESULTS:

Examination of section treated for estrogen receptors revealed moderate positive nuclear staining in 40% of tumor cells by chromogen.

Examination of section treated for progesterone receptors revealed moderate positive nuclear staining in 33% of tumor cells by chromogen.

Examination of section treated for Her-2/neu revealed moderate membrane staining in >10% of tumor cells by chromogen (score 2+).

Examination of section treated for Ki67 revealed positive nuclear stain in average of ±60% of tumor cells.

CONCLUSION:

Tumor Cells Were:

- > **Positive** For Estrogen Receptors, Score 6/8.
- > **Positive** For Progesterone Receptors, Score 6/8.
- > **Equivocal** For Her-2/neu (Score 2+).
- > 60% Proliferative index

COMMENT: All controls show appropriate reactivity.

DR. AYA MAGDY
DR. YOUSRA RAAFAT

Signature of Dr. Yousra RAAFAT



Presidential Initiative for Women's Health
Pathology Lab - Cairo University Hospitals
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي
مستشفيات جامعة القاهرة



IN SITU HYDRIDIZATION REPORT

NAME: أمينة عبد المنعم إبراهيم
PATIENT'S I.D.: 29005268800647
AGE: 32 Y.

TM : 64 S /2023

Specimen Received Data: 01 / 03 /2023
Date Report Issued: 04/ 03 /2023

CLINICAL DATA: A case of *right* breast cancer, for detection of HER2 amplification by dual in situ hybridization (DISH).

PROCEDURE: Tissue sections from paraffin block were used for quantitative detection of HER2 amplification using Ventana Benchmark Ultra System autostainer & VENTANA INFORM HER2 Dual DNA Probe Cocktail Assay.

RESULTS:

The HER2 NEU/ CEP 17 ratio was 6
HER2 copies were 9.9

COMMENT:

HER2 Status by DiSH: **AMPLIFIED**

DR. PASSANT ESSAM SHIBEL
DR. AYA MAGDY

A. Magdy

Passant

Patient name: OMNYA ABD ELMONAEM IBRAHEM	Age: 32 Years
Modality Name: CT	Study Date: 21/02/2023 12:38:43 ,
Patient id: 800647	

GIT IMAGING UNIT

POST-CONTRAST CT EXAMINATION OF ABDOMEN & PELVIS REVEALED:

- The liver is average size, showing smooth outline and homogenous parenchymal texture with no pathologically enhancing focal lesion. No dilated intra hepatic biliary radicles.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands IVC and aorta.
- Normal function and morphology of both kidneys.
- Prominent subcentimetric para-aortic, aortocaval and mesenteric lymph nodes, likely reactive.
- Normal urinary bladder and pelvic viscera.
- No ascites or pelvic collection.
- IUD is noted in situ.
- Small fat containing umbilical hernia.
- Bilateral sacroilitis, more evident on the left side.

OPINION:-

- No CT evidence of pelviabdominal metastatic deposits.

Dr. Marie N. Grace, MD

Res. Nema Aboelmagd

Patient Name: *Omneya Abd El-Monim Ibrahim*

Patient ID: *577354*

Exam Date: *16/3/2024*

^{99m}Tc -MDP WHOLE BODY BONE SCAN

Desired information:-

- skeletal survey.

Technique:

- anterior & posterior whole body e bone scan performed 2 hours following IV administration of 20 mCi $\text{Tc-}^{99m}\text{MDP}$.

Report:-

- No hot spot that may account for osseous deposits could be detected all over the rest of the surveyed skeleton.
- Degenerative changes at dorso-lumbar vertebrae, more at mid lumbar for follow up.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- *The surveyed skeleton is free of osseous deposits.*
- *Follow up bone scan is advised.*

Thanks;

Nuclear Dr. Huda Fathy, MD



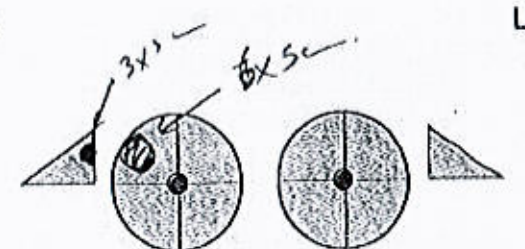
مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مدر

MDT FORM

15/3/2023 GA

Name	انيس عبد الحليم	MRN	٢٠٢٢/٩٦٦
Age	32	ID	٢٩٠٠٥٦٧٨٩٠٦٧
Menopausal status		Phone	٠١١٤٧١٩٤٩٧٢
NRS SCORE		Marital status	m.
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	Nov

Rt Breast.				Clinical Data	
BX: IDC/LC					
ER: 6/8	PR: 6/8	HER 2: +2 55H amp.	Ki67: 60%.		
Sonomammography: Rt-UCG 11 clock 3.2x3.8+LN. CE-SM unifocal					
Mets Workup: Pst					

Recommendations:

Feihad - clip inserted

① Bone scan

② Echo

③ Lab

MDT OUTCOME & PLAN

Start ① Tamoxifen (ovarian protection) ② NAT (TCR) with regular clinical assessment ③ Re-do mammography post-NAT the candidate for VTE & MND.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
D. F. ٢٠٢٢/٤/١٥					